

✓ 추나실습 써머리 가이드

- 중간(30%, 과제)+기말(30%)+출석(20%)+발표(10%, 기말 구두 시험)+실습태도(10%)
- 검은색: ppt 내용 / **붉고 빨간색 글씨: 강조** / 초록색: 교수님 설명
- (실습 중 첨언): 수업시간에 교수님에게 저희 조가 피드백 받은 내용입니다. 다른 피드백 받은 내용이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다.

7장 근육부 추나치료

홍채유돌근

- 기시: 복장뼈자루, 빗장뼈 안쪽 1/3
- 정지: 유양돌기, 위목덜미선
- 작용: 측굴, 회전

1) 촉진

- 환자: 눕거나 앉은 자세
- 의사: 환자의 머리를 반대쪽으로 회전, 동측으로 약간 굴곡시키고 저항을 가하면 관찰 가능

2) 단축평가



단축평가 ① (정상)

단축평가 ① (비정상)

단축평가 ②

- 평가 ①: 환자에게 “천천히 머리를 들어 턱이 가슴에 닿게 하세요.”라고 지시. 턱을 당기면서 경추가 굴곡되면 정상. 턱을 전방으로 내밀면서 머리를 들어올리면 단축

→ 홍채유돌근이 단축되거나 경추 심부 근육이 약하면 턱이 들리게 됨

→ 너무 심한 경우 인대의 골화 등을 의심할 수 있음

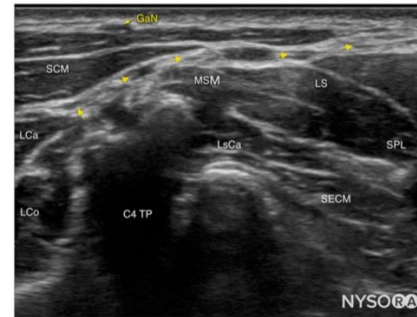
- 평가 ②: 정상인 경우 홍채유돌근은 눈에 잘 띄지 않는데, 단축된 경우에는 쇄골부착부 또는 특정 부위가 매우 쉽게 관찰된다.

→ 위 단축평가는 관찰에 문제가 크지 않다는 것을 전제로 근육의 기능만 살펴보는 것

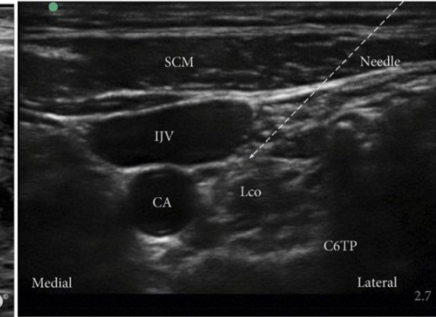
→ 체간의 불균형도 고려해야 함

초음파

① SCM 정지부



② SCM 중앙



→ SCM의 문제 이외에도, SCM 아래에 동맥과 정맥이 존재하고 경장근과 전사각근 사이에 ganglion(신경절)이 존재하는데, ganglion이 돌리면서 신경적인 문제(두통, 메스꺼움, 어지러움, 화끈거림 등)가 발생할 수 있음. 이때 scm을 치료하면, 주변 구조물도 같이 이완되면서 위의 문제가 해결될 수 있다.

(결론: SCM의 근육학적인 기능 이 외에 주변 구조물도 같이 생각해야 한다.)

3) 이완/강화기법

- 환자의 자세: 침대 상단 끝에 어깨를 두고 의사의 무릎 위에 머리를 받친 양와위
- 주동수: 홍채유돌근의 정지부인 환측 유양돌기에 접촉
- 보조수: 홍채유돌근의 기시부인 홍골에 접촉



(첨언) 홍골에 접촉할 때 환자의 손을 아래에 깔고 누르거나 수건을 대고 누르라고 함

- 시술방법: 머리를 약간 신전, 견측회전시키고 흡기상태로 숨을 멈추게 한 후 머리를 들어올리도록 지시하고 의사는 반대힘을 준다. 6~7 초 등척성 수축 유지 후 호기 유도. 이완된 상태에서 보조수로 홍골부착부를 족방으로 밀어주며 근육을 신장시킨다. 이를 3~4회 반복

(첨언 1) 머리가 침대 바깥으로 나가게 살짝 뒤로 넘겨야 함. 이때 회전을 한 상태에서 신전하면 기시, 정지가 가장 많이 늘어지기 때문에 회전을 하고 신전. 이때 머리는 다리로부터 높이 조절을 자유자재로 할 수 있게 함.

(첨언 2) 보조수로 기시부를 잘 고정해야 고개가 조금만 넘어가도 팽팽해짐. 고정이 안되면 많이 넘어가더라도 장력이 잘 걸리지 않음

(첨언 3) 주동수로 귀를 막지 않게 주의하고, 아래에 경동맥이 지나가기 때문에 지나치게 뒤로 넘기면 경동맥을 압박해서 어지러울 수 있음

- 시술 후: 스트레칭 10초. 과도한 목의 신전 금기. 환자의 노력과 저항은 통증이 유발되지 않는 적당한 수준이어야 함. 중년 및 노년의 환자들에게 시술 시 절대적인 주의 요망. (뇌혈류 문제를 평가할 수 있는 적절한 검사 시행 필요)

4) 신장기법

- 시작 자세: 의자에 앉아 한 손으로 의자를 잡고, 다른 손으로 흉쇄유돌근 기시부인 흉골 및 쇄골에 접촉하여 지그시 누른다.
- 턱을 당기면서 머리를 신전, 견축축굴 하고, 근육 긴장이 느껴질 때까지 견축 회전한다.
- 신장 상태를 10~15초 유지, 3~5회 반복

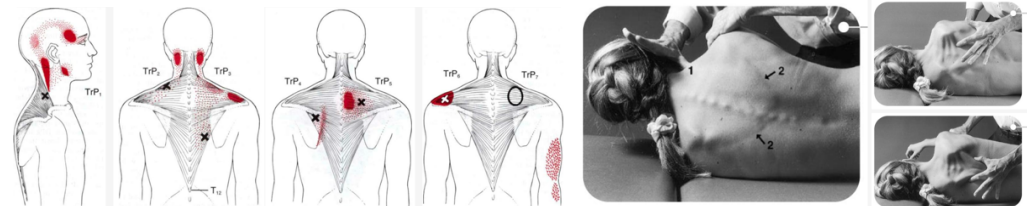


상부 승모근

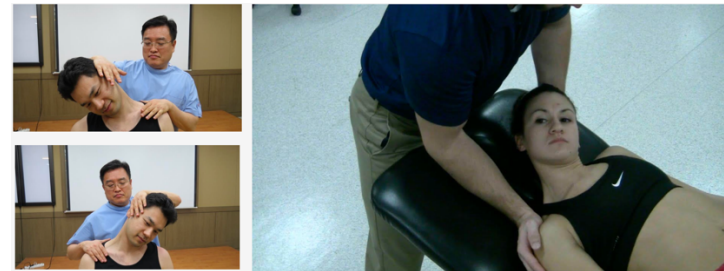
→ 아래 4개 근육은 교수님께서 피피티에 사진만 있어서, 교과서와 1학기 내용에서 설명을 가져왔습니다.

- 기시: 후두골 상향선, C1~C5 극돌기, 항인대
- 정지: 쇄골 외측 1/3
- 작용: (머리 고정 시) 견갑골 거상, 상방회전
(어깨 고정 시) 경추 동측 측굴, 대측 회전(편측 수축) / 경추 신전(양측 수축)

1) 연관통 & 촉진



2) 단축평가



- 환자의 뒤에 서서, 환자의 머리와 어깨를 촉진. 어깨를 하방으로 고정하고 머리와 목을 대측 측굴시킨다. 양측 모두 시행하여 움직임이 저하되거나 끝느낌이 부드럽지 못한 쪽에 승모근 단축이 있다.

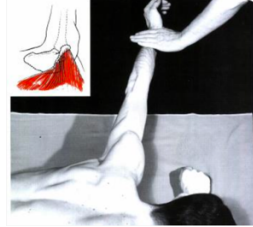
→ 앉아서 하면 체간이 일정하지 않기 때문에 누워서 진행

→ 쇄골 바깥쪽 1/3을 잘 고정된 상태에서 평가하며, 과도하게 측굴하지 않고 텐션이 느껴지는 지점까지만 측굴

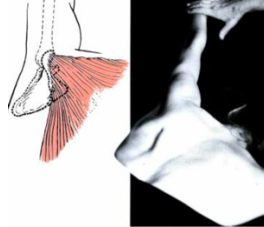
3) 근력평가



① 상부 승모근



② 중부 승모근

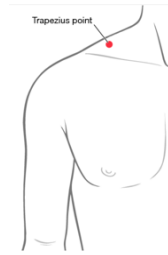


③ 하부 승모근

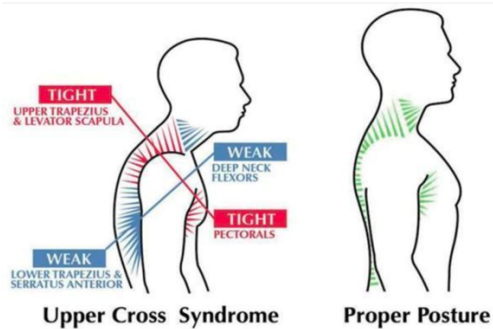
→ 라운드 숄더가 있으면 한 쪽 근긴장이 높아서 올라가게 됨. 치료를 할 때 환자가 근육에 힘을 평소에도 계속 준다는 사실을 인지시키는 것이 중요함

4) 압박/이완기법

- 압통점: 근복(전/후방 근섬유 경계부 중심에 주로 위치)
- 환자의 자세: 앙와위
- 의사의 자세: 환측에 선다.
- 압통점을 촉진한 채 환측 팔을 잡고, 견관절 굴곡, 외전, 외회전시켜 압통이 소실되는 최적의 편안한 위치를 찾아 유지. 이하 소흉근과 동일

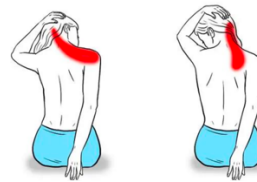


상부교차증후군



→ 흔히 구축되는 근육으로 활용빈도가 높음 (2주차 참고, 사진은 견갑거근과 상부 승모근)

5) 이완/강화기법



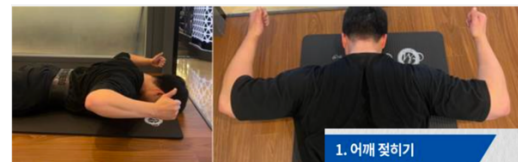
- 환자의 자세: 앙와위
- 주동수: 환자의 후두부
- 보조수: 상부승모근 정지부인 쇄골부착부
- 시술 방법 : 환자의 목을 굴곡, 견측 측굴시킴. 치료하고자 하는 근섬유 방향에 따라 회전을 시켜 제한장벽 확인. 중간범위로 돌아와 환자 흡기 상태에서 기시-종지가 가까워지는 방향으로 등척성 수축 유도 및 의사의 반대 힘 적용. 이하 대흉근과 동일
(첨언 1) 고개 방향에 따라 전부, 중부, 후부로 나뉘는데 중부는 안 해도 되고, 주로 전부와 후부 위주로 함 (전부 섬유 = 동측 회전 / 후부 섬유 = 대측 회전 / 중부 섬유 = 가운데)
(첨언 2) 흉쇄유돌근과 마찬가지로 쇄골의 부착부를 잘 고정된 상태에서 시행
(첨언 3) 머리 자체가 무겁기 때문에 보통 자신의 배로 머리를 비스듬히 세우듯이 고정 (베드 높이는 자기가 고정하기 편한 정도)
(첨언 4) 등척성 수축 시 전부 섬유는 "어깨를 들어올리고 고개는 어깨에 붙이세요"라고 말하며, 후부 섬유는 "고개를 들고 어깨를 붙이세요"라고 말하셨음

6) 스트레칭

- 시작 자세: 의자에 앉아 한 손으로 의자를 잡는다.
- 다른 손으로 머리와 목을 굴곡, 대측 측굴시켜 지긋이 누른다.
- 신장을 증대시키기 위해 의자를 잡은 손으로 체간을 하방으로 당긴다.(이때 턱을 밑으로 당기면 흉쇄유돌근의 신장을 더욱 증가시킬 수 있다.)
- 신장은 10~15초간 유지. 3~5회 반복. 양측 모두 시행
→ 의자를 잡아 어깨가 따라 올라가지 않게 함



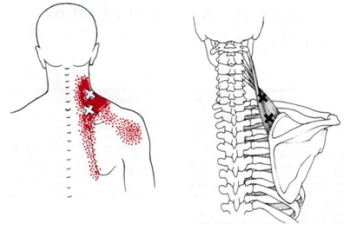
7) 강화운동 - 중/하부승모근



견갑거근

- 기사: C1~C4 횡돌기 후결절
- 정지: 견갑골 상각과 견갑극 root 사이 내측연
- 작용: (머리 고정 시) 견갑골 거상, 하방회전
(어깨 고정 시) 경추 동측 회전, 측굴(편측 수축) / 경추 신전(양측 수축)

1) 연관통

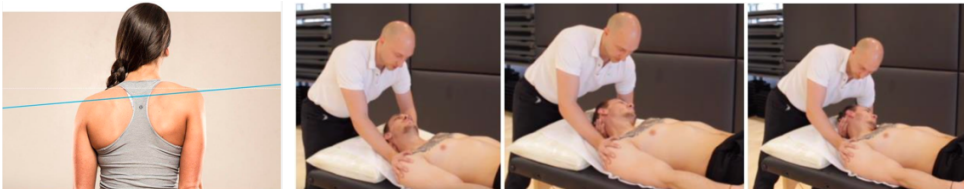


2) 촉진



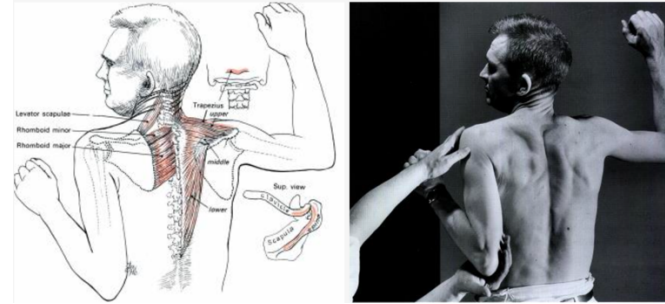
- 환자: 앉거나 옆으로 누운 자세
- 의사: 환자 머리를 반대쪽으로 약간 회전, 바깥쪽 측굴시키고 이에 저항을 주면 관찰 가능.
반복적으로 수축-이완하는 동안 촉진한다. → SCM, 승모근 사이에서 잘 촉진 됨

3) 단축 평가



- 육안으로 어깨뼈 상각이 얼마나 들어올려져 있는지 보고, 부착부 촉진을 통해 압통이 얼마나 심한지 등 전반적으로 확인
- 이 외에 누워서 고개를 굴곡하지 않고 측굴, 회전만 이용해서 평가할수도 있음 (굴곡하면 승모근이 개입하기 때문)

4) 근력 평가



5) 압박/이완기법



- 압통점: 주로 경추 횡돌기-견갑골 상각까지의 주행경로 중 근섬유 교차지점에 위치
→ C5~C6 측면에 압통점이 존재 (섬유가 꼬이는 지점에 많이 발생)
- 환자의 자세: 좌위
- 의사의 자세: 환자의 환측 뒤에 선다.
- 치료: 압통점을 찾아 촉진한 채 머리를 신전, 목을 동측 회전/측굴하여 압통점이 소실되는 최적의 편안한 위치를 찾아 유지.
→ 승모근은 흡기한 상태에서 진행했다면, 견갑거근은 호기한 상태에서 진행. "숨을 크게 내쉬세요"라고 한 뒤, 다 내쉬 상태에서 숨을 5초정도 참게하기. 이를 3~5회 반복 후 수동적으로 원위치 시킴 (항상 모든 기법은 환자가 스스로 원위치하면 안 됨)
→ 책에서는 이완기법으로만 적혀 있어서 위의 설명을 참고하면 될 것 같음

6) 이완/강화기법



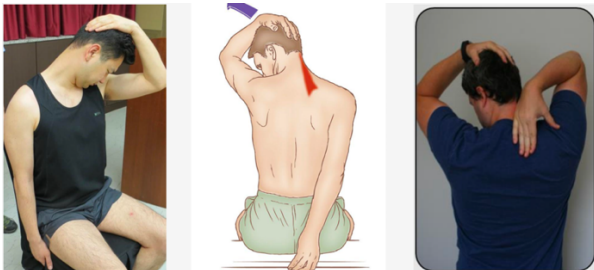
- 환자의 자세: 환측 상지를 회외, 내전시켜 손을 둔부 아래에 깔고 눕는다.
- 주동수: 환자의 후두부
- 보조수: 견갑골 상각의 견갑거근 부착부
- 시술방법: 주동수로 환자의 목을 굴곡, 건측 측굴한 상태에서 건측으로 회전한 상태에서 제한 장벽 확인 후 중간범위로 되돌아간 상태에서 환자에게 숨을 들이 쉬게 한 후 멈추고 근육의 기시와 종지가 가까워지는 방향으로 등척성 수축(최대 힘의 20%)을 하도록 하면서 의사는 동일한 반대 힘을 준다, 6~7초 정도 후에 환자가 숨을 내쉬게 한 다음 이완된 상태에서 새로운 제한장벽까지 근육을 신장시킨다. 이것을 3~4회 반복한다.

(첨언 1) 어깨가 잘 따라 올라가기 때문에 견갑골 안쪽 상각을 고정하는 것이 중요.

(첨언 2) 몸에 팔꿈치를 붙여 고정한 상태에서 견갑골을 쪽 늘림. 이때 너무 늘리면 견갑골이 들어 올려지기 때문에 견갑골이 올라가지 않을 지점이 제한 장벽. 이후 흡기한 상태에서 숨을 약 7초정도 참고 내쉬 뒤, 4초정도 휴지기를 가지고 다시 제한장벽을 찾고 시행

(첨언 3) 고개를 옆구리에 끼고 쪽 늘려주며, 방향은 목을 뒤로 젖히는 방향으로 시행

7) 스트레칭

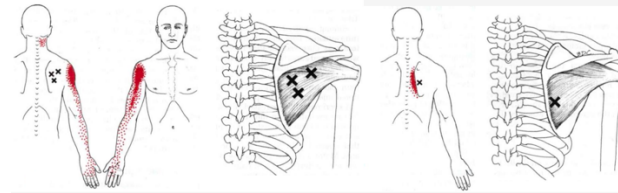


- 시작 자세: 의자에 앉아 환측 손으로 의자를 잡게 하거나 엉덩이 밑에 손을 깔고 앉게 한다. 다른 손으로 머리를 굴곡, 건측측굴, 건측회전하도록 한다.
- 체간을 반대쪽으로 기울이고, 머리와 목에 접촉한 손에 의해 당겨지지 않도록 한다.
- 동측 하부승모근의 수축에 의해 신장이 증가될 수 있다.
- 신장을 10~15초 유지, 3~5회 반복.

극하근

- 기시: 견갑골의 극하와 내측 2/3
- 정지: 상완골 대결절 후면
- 작용: 상완 외회전

1) 연관통



2) 촉진



→ 외회전하면 근육이 수축

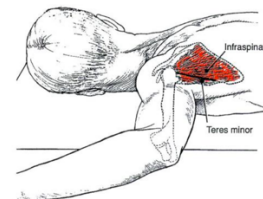
3) 단축평가



(왼쪽) 이 자세에서 시행하며, 누워서 어깨를 90도 외전하고 팔꿈치를 90도 굴곡시킨 상태에서 안쪽으로 내회전을 시행. 정상적인 경우 베드에 손가락이 끝이 닿을 정도 내려감.

(오른쪽) 극하근이 단축된 경우 조금 될 수 있지만, 견갑하근이 단축되면 거의 안 됨

4) 근력 평가



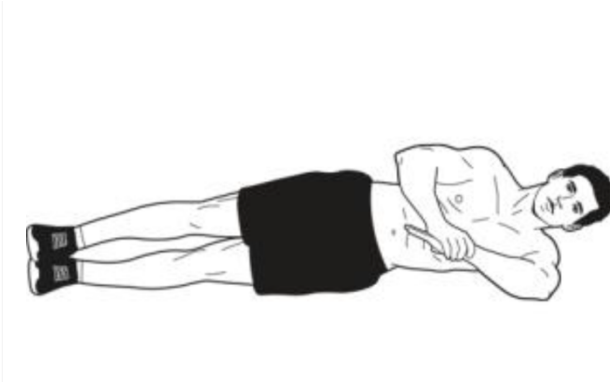
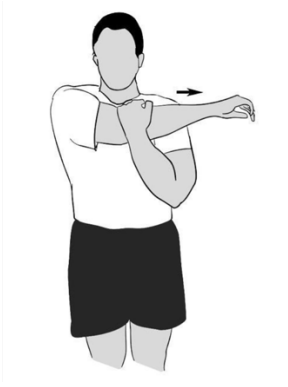
→ 손을 밑에서 받치고, 외회전을 시킴

5) 이완/강화기법



- 내회전하는 방향으로 늘려주면서 제한장벽을 찾고 환자는 외회전 하는 힘을 주게 하여 등척성 수축을 시행.
- 견갑대가 원래 30도가 유지되어야 하기 때문에 견갑골 아래 수건을 깔아 둬
- 이때 어깨가 들리지 않도록 주의해야 함

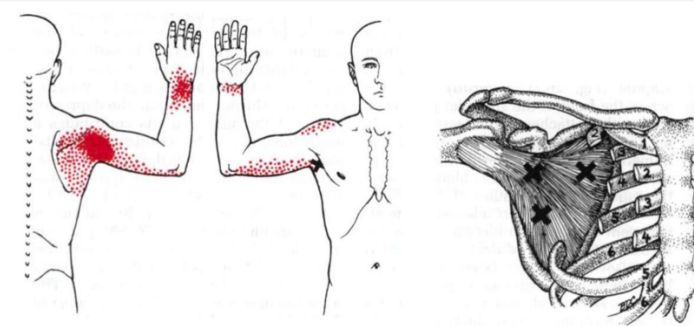
6) 스트레칭



견갑하근

- 기시: 견갑하와
- 정지: 상완골 소결절
- 작용: 상완 내회전

1) 연관통



→ 상완 내측과 손목에 띠를 두른 듯한 연관통이 발생할 수 있음

2) 촉진

- 견갑골을 흉곽에서 떨어뜨리고 뒤쪽의 광배근과 앞쪽의 대흉근 사이에서 견갑골 앞면으로 미끄러져 들어가 촉진한다.
- 외전시킨 상태에서 광배근을 파고들어 만지면, 끝의 모서리 정도가 만져질 수 있음

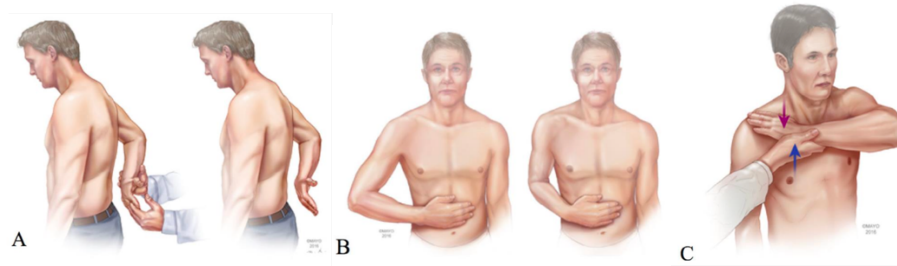


3) 단축평가



- 환자는 바로 누워 어깨를 90도 외전, 주관절을 90도 굴곡하고, 전완을 외회전하여 손바닥을 위로 향하게 한다. 견갑하근이 단축된 경우 전완이 바닥과 평행하게 되지 않고 약간 거상
- 극하근과 반대. 원래는 외회전이 90도가 되어야 하는데 단축이 있으면 짧아져서 안 됨. 양측을 비교했을 때 떠 있는 쪽이 단축

4) 근력 평가



5) 압박/이완기법



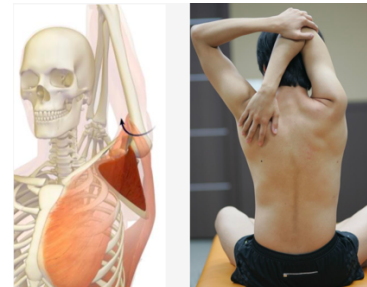
- 압통점: 견갑골 외측면(lateral border) 앞쪽 내측 경계에 근접하여 위치한다.
- 환자의 자세: 침대 가장자리에 앙와위
- 의사의 자세: 환측 체간 하부 쪽에 앉는다.
- 치료: 압통점을 촉진한 채 환자의 전완을 잡고 견관절을 외전, 신전, 내회전한 상태에서 약간 팔을 들거나 당기는 미세조절을 통해 압통점이 소실되는 최적의 편안한 위치를 찾아 유지. 이하 소흉근과 동일
- 극하근과 달리 촉진이 되기 때문에 압박/이완기법이 존재
- (첨언 1) 교수님께서서는 엄지손가락을 제외한 나머지 손가락을 환자 등 아래로 놓고, 엄지손가락으로 근육을 누르면서 진행하심.
- (첨언 2) 모든 압박/이완기법에서 근육을 압박하는 손을 땀다 붙였다하면 안됨.

6) 이완/강화기법



- 환자의 자세: 팔꿈치를 테이블 가장자리에 놓은 앙와위
- 주동수: 환자의 손목을 잡는다.
- 보조수: 상완골 전면에 대고 어깨를 고정한다.
- 시술 방법: 보조수로 어깨를 고정한 상태에서 환자의 전완을 잡고 외회전의 제한장벽 확인. 이하 극하근과 동일.
- 시술 후: 스트레칭 10초
- (첨언 1) 극하근과 자세는 동일하고 방향이 반대. 마찬가지로 수건을 아래에 깔아두고, 어깨가 들리지 않게 조심하면서 내회전 방향의 힘을 주게 하기. 약 8초간 등척성 수축을 시행하고, 4초정도의 휴지기를 가짐.
- (첨언 2) 각도에 너무 집착하지 않고 시행. 체간을 팔꿈치에 붙인 상태에서 돌려도 됨
- (첨언 3) 견관절을 잘 고정한 상태에서 환자의 팔꿈치를 잡고, 환자는 의사의 팔꿈치를 잡게 한 상태에서 시행
- (첨언 4) 이정한 교수님 방법: 어깨를 잡은 상태에서 최대한 몸을 밀착하고, 상완부로 환자의 상완부를 밀착한 자세에서 환자의 손을 주먹 쥐게 하고 반대손으로 잡고 시행

7) 스트레칭



- 손을 머리 위로 올려 건측 손으로 환측 팔꿈치를 눌러 외전과 외회전이 되도록 한다.